

基药目录首纳创新药系列研究

政策传导非线性

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-10

摘要

医保、基药、商保三套目录形成多层次准入协同体系，推动创新药估值锚从"管线概率折现"迁移到"商业化兑现质量"。但本报告认为，多目录协同不等于同一时点共振，政策到业绩之间的传导存在多个断点。基药目录动态调整机制是否成为可持续制度变量，决定估值修复是中枢上移还是主题扩张。当前板块处于"龙头验证"向"路径复制"过渡期，尚未进入全面配置扩散期。板块系统性流入需要宏观贴现率、盈利可见度、资金迁移路径、政策叙事强度四层变量逐级接力，缺一不可。投资者需要区分"政策驱动"和"基本面驱动"两种行情性质，避免把"政策可及性"等同于"盈利可验证性"。只有经营变量和验证变量同步改善，板块风险偏好外溢才能从主题交易升级为系统性配置。

CHAPTER 01

多目录协同推动估值锚迁移

■ 医保谈判不再是终点而是起点

2024年，33个创新药在获批当年就进入医保目录。这个数字在八年前还是零。中国创新药的定价叙事，正在从“能不能批”转向“能卖多少”。

过去十年，投资者给创新药企业定价，用的是一套研发叙事。管线上有几个三期分子，靶点稀缺性如何，临床数据是不是阳性——这些变量决定了估值。一家公司哪怕连年亏损，只要手里攥着三四个后期临床项目，市值就能站上几百亿。这套框架的本质，是把“未来的可能性”当成“现在的确定性”来卖。

2020年之前，这个方法有效。那时候多数创新药还没上市，报表上看不到销售收入，投资者只能用管线数量、靶点稀缺性、临床数据来定价。但2024年之后，这个框架开始松动。松动的原因不是某一份文件，而是支付准入体系的系统性升级。

医保目录从八年一调变成每年一调。新药从获批到进医保，平均时间从五年压缩到一年。2024年，当年获批、当年上市、当年进医保的品种达到33个。准入不再是一道漫长的选择题，而变成了一道在短时间内完成的必答题。

这道必答题的后面，还跟着更多选项。2025年政府工作报告首次提出建立商业健康保险创新药品目录。它的定位很清楚：不是替代医保，而是延伸医保。医保保基本，商保补创新。临床价值突出但价格超出医保承受能力的创新药，可以先进入商保目录，在商保的支付框架里快速落地。商保目录内的药品不纳入医保自费率指标，不纳入集采中选可替代药品监测，还可以不纳入按病种付费范围。这等于给创新药开辟了一条与医保并行的独立支付通道。

基药目录也在加速。2026版基药目录从685个品种大幅扩容到980个左右，净增约300个品种。这是自2012年以来增幅最大的一次。更重要的是，本轮基药目录明确纳入已通过医保谈判验证过的50种1类创新药。创新药不再只是停留在报销层面，而是可以进一步下沉到基层医疗机构，获得更广泛的处方覆盖。

三套目录——医保、商保、基药——形成了一个多层次的准入协同体系。医保解决“能不能报”，商保解决“高价创新谁买单”，基药解决“基层医院能不能用”。对于创新药企业来说，支付端不再是单一的谈判降价游戏，而是一个多维度、多批次、多层次的准入工程。企业可以根据产品的价格带、适应症人群、临床定位，选择不同的准入路径组合。

估值的核心变量正在发生迁移。投资者不再只是问"这个药能不能批",而是开始问"进了医保之后能覆盖多少家医院""每家医院月均处方量能到多少盒""商保能额外贡献多少销量""基药下沉能打开多大基层市场"。这些问题的答案不再是概率论,而是经营数据。估值从"管线概率折现"迁移到"商业化兑现质量",创新药企业的估值逻辑从远期研发叙事转向了近端经营指标。

■ 覆盖医院数与单院产出成为新估值坐标

估值锚迁移之后,投资者需要一套新的坐标。这套坐标的核心是两个指标:覆盖医院数和单院产出。前者衡量准入广度,后者衡量准入深度。两者相乘,就是一家企业当下的真实商业化能力。

过去评估院端准入,大家习惯性地看一个笼统指标——"进院率"。但这个指标有误导性。全国有3300家三甲医院,一家企业的产品进入其中300家,进院率不到10%。问题在于,这10%的医院可能覆盖了全国70%到80%的处方量。很多专科药物的处方高度集中在头部医院,尤其是肿瘤、罕见病、精神神经等领域,Top100医院的销量就代表了整个市场的绝大部分。进院不能只看数量,还要看处方潜力。

更进一步的指标是单院产出。产品进入了一家医院,月均处方量是500盒还是5000盒,直接决定了这家医院的商业价值。这个数字取决于多个经营变量:医院科室的学术认知程度、药事会的准入效率、临床医生的用药习惯、竞品在院内的覆盖情况、企业的学术推广力度。这些都不是政策能直接解决的,而是需要企业一支成熟的销售团队去逐个医院、逐个科室、逐个医生推进。

当投资者开始用"覆盖医院数季度增速"和"单院月均产出"来追踪经营进展时,估值方法论就变了。以前看管线,只需要看临床数据是不是阳性;现在看商业化,需要追踪每季度新开了多少家医院、每家医院发货量是否在爬坡、月均发货量从3万盒到10万盒再到13万盒的爬坡斜率有多陡。这些数据的颗粒度远比临床数据更细,也更能反映真实经营能力。

这种变化对不同类型企业影响不一样。对于已经具备成熟销售体系的龙头企业,估值锚迁移是利好。它们有现成的销售团队、医院关系、学术网络,新产品放量速度可以很快。投资者愿意为这种"可验证的兑现能力"支付更高的估值溢价。但对于还在靠BD交易或早期管线支撑估值的Biotech企业来说,这意味着压力。如果第一个商业化产品迟迟打不开院端局面,或者单院产出一直停留在低水平,市场就会质疑它们的商业化基因,估值里原有的管线溢价就会缩水。

■ 支付闭环与执行闭环共同构成估值基础

创新药的收入能见度提升，需要两个闭环同时成立：支付闭环和执行闭环。

支付闭环解决“钱从哪里来”。在医保、商保、基药的多目录协同体系下，支付闭环的构成变得更加多元。医保支付提供最基本的覆盖，但谈判降价和支付标准的约束意味着利润空间有限。商保支付则提供重要补充——商保目录内药品价格可以高于医保，且医保局不组织带量采购，企业可以保留更高利润空间。但商保的支付规模取决于保险产品的投保人群和保费水平，目前商保总保费收入接近1万亿，但商业健康保险在保障效能和资金使用效率上还有很大提升空间。基药支付打开了基层市场通道，但基药目录药品定价通常更严格，企业需要以量换价。

执行闭环解决“药怎么卖出去”。这包括药事会的召开频率、医院用药目录的动态调整机制、一品两规限制的破除、临床医生的学术认知、患者的用药可及性。这些环节每一个都可能成为断点。政策已经明确医保目录内创新药不受一品两规限制，但医院在实际执行中是否完全放开，仍然取决于药事管理流程。政策要求医院及时召开药事会完善药品配备，但不同医院召开频率差异很大，有的医院一年开一次，有的医院一年开四次。这直接影响了创新药进入院内目录的速度。

当支付闭环和执行闭环同时成立，创新药的收入曲线就变得更可预测。企业可以比较准确地预测，一款产品进入医保目录后第一年能覆盖多少家医院，第二年单院产出能提升到多少，第三年商保能额外贡献多少销量。这种可预测性意味着远期概率折现的权重下降，即期经营兑现的权重上升。估值容忍度从“你未来可能值多少钱”向“你现在每个月能卖多少药”倾斜。不是说研发管线不再重要，而是管线的价值需要通过商业化能力来兑现。商业化能力的验证，正在成为估值的第一道门槛。

CHAPTER 02

政策到业绩的传导并非线性

■ 多目录协同不等于同一时点共振

多目录协同体系是一个重大的制度进步，但它不等于所有目录在同一时间点对同一款产品产生叠加效应。医保、基药、商保三套目录之间的传导存在多个断点，同一批准入的药品可能被“环节切割”为多批次上量。

医保目录调整每年一次，从申报到落地通常需要半年到一年。形式审查、专家评审、药物经济学测算、价格谈判——每一个环节都要排队。即使产品成功纳入医保目录，从目录公布到各省实际执行还有一个时间差。医保目录是中央层面制定

，但支付落地是省级统筹。不同省份的医保基金承受能力、目录对接流程、信息系统改造进度都不一样，同一款产品在不同省份的实际报销时间可能相差几个月。

基药目录的调整周期更长。上一轮基药目录调整是2018年，到2026年才推出新版，中间间隔了七年。即使新版基药目录落地，从目录公布到各级医疗机构完成采购目录调整、药事会审议、库存更替，也需要一个漫长的过程。基层医疗机构的采购能力和用药习惯与三甲医院差异很大，一款创新药即使进入基药目录，能否真正在基层放量还取决于县域医共体的采购决策、医生培训、患者认知等多个因素。

商保创新药目录的落地速度理论上最快，因为价格协商机制更灵活，不需要像医保那样经过复杂的谈判程序。但商保目录的实际支付规模取决于商业保险产品的设计。保险公司是否将目录内药品纳入产品报销范围，取决于精算结果、保费定价、市场竞争等多种商业因素。商保目录是推荐性目录，不是强制性目录，保险公司有权选择是否采用。即使一款药品进入商保创新药目录，也不等于自动获得了规模性覆盖。

三个目录之间的时间差和制度差，意味着创新药的上量是一个分阶段、分批次、分区域的渐进过程，而不是政策出台后所有通道同时打开的共振过程。企业需要为每个目录单独准备申报材料，应对不同评审标准，制定不同价格策略，跟踪不同落地进度。对于投资者来说，不能把“纳入目录”等同于“业绩释放”，而需要关注每个目录的落地节奏和实际贡献。

■ 基药动态化能否成为可持续制度变量

基药目录的动态调整机制是本轮制度变革中一个非常关键的变量。2026版基药目录管理办法明确提出，基药目录将实行动态调整，原则上不超过三年调整一次。如果这条机制能够真正落地，基药目录将从过去的静态目录变成动态迭代的制度工具，对创新药的基层准入具有深远意义。

但“动态化”能否从纸面制度变成实际执行的可持续变量，现在还面临诸多不确定性。上一轮基药目录从2018年到2026年，整整七年没有调整，远远超过了当时规定的三年周期。制度设计是一回事，实际执行是另一回事。基药目录的调整涉及卫健委、医保局、药监局、地方政府等多个部门，协调成本非常高。而且基药目录的调整不仅需要新增品种，还需要调出老旧品种，这涉及既有利益格局的调整，阻力不小。

如果基药动态调整机制能够常态化运行，创新药进入基层市场的通道就会保持畅通。企业可以预期，只要在医保目录内验证过临床价值，就有较大机会在下一轮

基药目录调整中被纳入。这种可预期性本身就会提升创新药的估值，因为基层市场的准入不是一次性的机会窗口，而是一个持续开放的制度化通道。投资者可以把这个因素纳入企业的长期销售峰值预测，从而提升对远期现金流的估值。

但如果动态调整机制在实际执行中再次陷入停滞，比如三年之后又拖成五年、七年，基药对创新药估值的贡献就会大打折扣。它可能变成一次性事件——本轮纳入的品种获得一次性的基层放量机会，但后续上市的创新药则面临漫长的等待。在这种情况下，估值修复的性质就不是中枢上移，而是主题扩张。只有本轮纳入基药的品种受益，板块的系统性估值提升不会发生，投资者只是在不同品种之间进行轮动交易，而不是对创新药板块整体提高估值容忍度。

基药动态化不是一个可以自动假设成立的变量。它需要持续观察实际的调整频率、纳入和调出的机制透明度、地方政府执行的到位程度。只有当这些配套环节都跑通之后，基药动态化才能成为推动创新药估值中枢上移的可持续力量。

■ 目录纳入不等于实际采购

这是一个在分析创新药政策时经常被忽视，但又极其关键的细节。目录准入和实际采购之间隔着一道“最后一公里”的鸿沟，这道鸿沟的宽度直接决定了政策红利能兑现多少。

医保目录准入只是解决了“这个药可以报销”的问题，但“这个药能不能在医院买到”取决于医院是否把药品纳入自己的用药目录。根据第三方数据，2015年至2024年我国批准上市的创新药中，能进入北京和广东地区三级医院用药目录的药品分别占50.6%和49.1%，但平均进院率分别只有12.6%和10.4%。几乎有一半的创新药虽然在理论上可以报销，但在实际医院采购中并没有落地。

进院率低的原因是多方面的。很多医院召开药事会的频率很低，一年一次甚至两年一次，新上市的创新药需要等待药事会召开才能审议是否纳入院内目录。虽然政策要求医保目录内创新药不受一品两规限制、不受药占比限制，但医院在实际管理中仍然面临DRG/DIP付费的压力。创新药通常价格较高，如果大量使用，会拉高科室药品费用，影响DRG成本控制和绩效考核。很多创新药是新的作用机制或新的治疗靶点，临床医生需要经过学术培训和实际使用经验的积累，才能形成稳定的处方习惯。这不是政策文件能一蹴而就的。

基药目录的情况也类似。虽然政策要求基层医疗机构“应配尽配”，但基层医疗机构的采购能力、冷链物流、医生诊疗水平都有限。一些需要特殊储存条件的生物制剂，在基层可能根本无法使用。还有一些靶向药需要基因检测等伴随诊断，基层往往不具备相应检测能力，即使药品进入基药目录，也无法真正处方给患者。

商保目录的落地瓶颈在于保险公司的产品设计。商保创新药目录是推荐性目录，保险公司是否纳入取决于产品的定价和精算。如果目录内药品价格过高，保险公司可能会选择不纳入，或者设置较高的免赔额和共付比例，患者的实际获得感就会打折扣。而且商保的投保人群相对有限，普惠性商业健康保险虽然覆盖人群较广，但保额通常不高，对于高价创新药可能仍然无法提供充分的支付保障。

即使一款创新药同时进入医保、基药和商保目录，它的实际销售放量仍然会受到医院准入、医生处方、患者支付能力、物流配送等多重因素的限制。政策到业绩之间的传导不是一条直线，而是一条布满断点和减速带的曲线。投资者在评估创新药企业的业绩潜力时，需要把这些实际执行层面的障碍纳入考量，而不能仅仅依据目录准入的清单来判断。

CHAPTER 03

风险偏好外溢需要盈利可验证性确认

■ 系统性流入需要三层确认

创新药板块的风险偏好外溢不会轻易发生。它需要三层确认逐步叠加，才能推动资金从主题交易转向系统性配置。

第一层是估值框架的切换。随着多目录协同体系的建立，市场开始认识到创新药的估值锚正在从管线概率折现向商业化兑现质量迁移。一些具备成熟销售体系、已经实现盈利或接近盈利的龙头企业，率先享受了估值修复。估值倍数从管线估值溢价向经营估值溢价转变。但这一层确认本身还不足以支撑系统性流入，因为它只解决“估值方法变了”的问题，没有解决“这个板块能不能持续赚钱”的问题。

第二层是业绩兑现的验证。估值框架切换之后，市场需要看到企业的财务报表上出现真实的收入加速和利润率改善。不是一个季度的数据就能说服，需要连续几个季度的收入增速环比提升、毛利率和净利率的同步改善、经营性现金流转正。只有当这些数据持续出现，投资者才能确信估值框架的切换不是纸上谈兵，而是有真实的经营基础支撑。业绩兑现验证是三层确认中最关键的一层，因为它直接把政策叙事和估值逻辑转化为可量化的财务回报。

第三层是政策预期差的收敛。市场预期差有两种：一种是乐观预期差，即市场高估了政策到业绩的传导速度和力度；另一种是悲观预期差，即市场低估了政策红利的持续性。只有当乐观预期差被逐步消化，或者悲观预期差被逐步修正，板块的风险偏好才能稳定在一个新的中枢水平上。如果乐观预期差过大，一旦出现业

绩低于预期的情况，就会引发估值的快速回调。如果悲观预期差持续存在，即使业绩兑现了，资金也会因为担忧政策不可持续而保持观望。

三层确认的顺序不能颠倒。估值框架切换是第一阶段，提供叙事的转变；业绩兑现验证是第二阶段，提供数据的支撑；政策预期差收敛是第三阶段，提供情绪的稳定。只有当三层确认都完成，创新药板块才能从主题交易升级为系统性配置。在此之前，任何单一政策变量——医保目录扩容、商保目录出台、基药目录调整——都只能形成阶段性的主题弹性，而不能推动板块进入全面配置扩散期。

■ 经营变量与验证变量同步改善是临界点

在三层确认框架中，第二层确认——业绩兑现验证——是最核心的临界点。而这个临界点需要两个变量的同步改善来标志：经营变量和验证变量。

经营变量是过程指标，衡量企业是不是在做对的事情。核心指标包括：覆盖医院数的季度增速、单院月均产出的爬坡斜率、商保目录的额外覆盖贡献、基药下沉后的基层市场渗透。这些指标反映的是企业商业化执行的进度，而不是最终的财务结果。即使企业还在亏损，如果经营变量在持续改善，市场就会愿意给予一定的估值容忍度，因为这意味着亏损正在收窄，盈利拐点正在接近。

验证变量是结果指标，衡量企业的财务报表上是否出现了预期的改善。核心指标包括：营业收入的同比增速、毛利率的变化趋势、销售费用率的优化幅度、归母净利润的盈亏拐点、经营性现金流的正负转换。这些指标直接反映企业的盈利能力和财务健康状况，是投资者最终能获得回报的来源。

当经营变量和验证变量同步改善，意味着创新药企业的商业化叙事正在从“讲故事”转向“看数据”。投资者可以看到，医院覆盖在增加，同时收入在增长；单院产出在提升，同时毛利率在改善；商保和基药的贡献在扩大，同时销售费用率在被摊薄。这种正向反馈的闭环一旦形成，就会吸引更多长期资金进入板块，因为这意味着创新药企业的商业模式正在跑通，估值修复有坚实的基本面支撑。

但如果只有经营变量改善而验证变量没有跟进，就会出现“叫好不叫座”的情况。企业每个季度都在报告新开了多少家医院，但收入增速始终起不来，或者毛利率持续下降。这可能意味着医院覆盖的质量不高，或者单院产出爬坡比预期慢，或者销售费用的投入产出比不理想。市场就会质疑经营变量的改善能否最终转化为盈利，估值修复就会停滞。

反之，如果只有验证变量改善而经营变量没有跟进，这种改善往往是不可持续的。企业某几个季度因为一次性因素收入大增，但医院覆盖和单院产出没有实质性变化，市场会判断这种改善是偶发的，而不是商业模式的质变，估值提升也就缺乏持续性。

真正的临界点是经营变量和验证变量的同步共振。只有当两者同时改善，投资者才能确信创新药板块的估值修复不是主题炒作，而是基本面驱动的系统性重估。这个共振点一旦出现，板块的风险偏好就会从龙头企业的局部外溢，向更多具备相似商业化能力的二线品种扩散。

■ 仅有政策变量改善则停留于主题交易

如果市场的关注点只停留在政策变量本身，而经营变量和验证变量没有同步跟进，创新药板块的上涨就只能停留在主题交易层面。主题交易的特点是，资金围绕政策事件进行快速进出，估值随政策预期而波动，缺乏持续的基本面支撑，行情容易来得快去得也快。

政策变量包括：医保目录新增了多少个创新药、商保目录是否出台、基药目录何时扩容、某个地方政府是否出台了支持创新药的特殊政策。这些变量本身确实重要，因为它们是制度环境改善的信号。但政策变量有一个天然的局限：它只解决"准入"的问题，不解决"放量"的问题。一款药进了医保目录，不等于它就能卖得好；商保目录出台了，不等于保险公司就会大规模纳入；基药目录扩容了，不等于基层医院就会大量采购。

在政策变量改善的初期，市场往往会给予较高的预期溢价，因为投资者会把政策红利线性外推到业绩释放。但过了几个季度，如果财务报表上没有看到相应的收入加速，预期就会回落，估值也会跟随调整。这种"预期高涨—业绩落空—估值回落"的循环，在A股和港股的创新药板块已经反复出现过多次。

投资者需要区分"政策驱动"和"基本面驱动"两种行情的性质。政策驱动行情的典型特征是：行情启动与政策事件高度相关，比如医保目录公布当天或前后几天出现脉冲式上涨；行情领涨的品种往往是政策直接受益的标的，而不是基本面最扎实的企业；行情持续性取决于后续是否有更多政策跟进，而不是业绩是否兑现。基本面驱动行情的典型特征则是：行情启动与业绩报告周期高度相关，比如季报或年报披露前后出现持续性上涨；行情领涨的品种是那些经营变量和验证变量同步改善的企业；行情持续性取决于基本面趋势是否延续，而不是政策事件是否密集。

当前创新药板块正处于从政策驱动向基本面驱动切换的过渡期。多目录协同体系的建立为基本面驱动提供了制度基础，但切换能否完成，取决于未来几个季度企业的经营数据和财务数据是否真正跟上。如果跟不上，板块的风险偏好外溢就会停留在主题交易层面，资金在龙头和主题之间轮动，而不是系统性加仓整个板块。

CHAPTER 04

板块处于龙头验证向路径复制过渡期

■ 多目录协同改善院端可及性但存在衰减

多目录协同体系确实显著改善了创新药的院端可及性，但政策从目录层面向处方层面的传导存在明显的衰减效应。这种衰减不是政策设计的问题，而是医疗系统复杂性的必然结果。

第一层衰减发生在医院管理层。政策要求取消医疗机构药品配备总品种数的限制，要求医院及时召开药事会完善药品配备，要求医保目录内创新药不受一品两规限制。但医院在执行这些政策时，会受到自身管理体系、科室利益、药品供应链管理等多重因素的制约。有的医院管理灵活，药事会一年开多次，新药准入流程顺畅；有的医院管理僵化，药事会一年开一次，新药需要排队等待。医院虽然取消了药品总品种数限制，但药房的空间和人力是有限的，不可能无限扩容，新增药品必然面临与既有药品的竞争。

第二层衰减发生在科室层面。即使药品进入医院的用药目录，最终能否被处方还取决于临床科室的接受程度。科室主任和主治医师对新药的认知程度、学术培训的参与度、既往用药习惯、对创新药安全性的顾虑，都会影响处方行为。很多创新药需要改变现有的诊疗路径，比如从化疗切换到靶向治疗，或者从单药治疗切换到联合治疗。这些改变需要医生重新学习诊疗指南，更新临床思维。这不是政策文件能直接推动的，需要企业大量的学术推广和临床教育。

第三层衰减发生在患者层面。即使医生愿意处方创新药，患者是否愿意接受还取决于药品的自付比例、患者的经济条件、对创新疗效的认知、对医保报销流程的熟悉程度。很多创新药虽然在医保目录内，但报销比例并不是100%，患者仍然需要承担一部分自付费用。对于一些高价创新药，即使自付比例只有20%，绝对金额也可能高达几千甚至上万元，这对普通患者仍然是很大的负担。商保目录虽然可以提供补充支付，但商保的覆盖人群和保障水平有限，很多患者并没有购买相应的商业健康保险。

三层衰减叠加在一起，意味着目录准入到实际处方之间有一个显著的折扣系数。这个折扣系数因药品类型、治疗领域、医院级别、地区经济水平而异。对于肿瘤等大病领域的创新药，因为患者支付意愿强、医生使用动力大，折扣系数可能较小；对于慢性病领域的创新药，因为患者自付压力大、医生替换惯用药的动力不足，折扣系数可能较大。对于三甲医院，因为学术氛围浓、药事管理规范，折扣系数可能较小；对于基层医疗机构，因为诊疗能力和采购能力有限，折扣系数可

能较大。

当前创新药板块正处于"政策可及性已经打开，但处方可及性仍有折扣"的过渡态。多目录协同体系解决了政策层面的准入问题，但执行层面的处方转化仍然需要时间。龙头企业因为已经建立了成熟的学术推广体系和医院关系，能够更快地把政策红利转化为处方增量，所以率先享受估值修复；但二线及以下企业因为缺乏同样的执行能力，政策红利到业绩的传导就会更慢、更弱。

■ 板块更像过渡态而非终局态

当前创新药板块的整体特征更像一个过渡态，而不是一个已经定型的终局态。过渡态是指板块的风险偏好已经开始外溢，但外溢的广度和深度还不够，尚未完成从龙头企业向二线品种的全面扩散。终局态是指板块的估值框架已经切换完成，业绩兑现已经充分验证，政策预期差已经收敛，资金配置已经从局部走向全面。

当前板块的几个特征支持过渡态的判断。第一，估值修复主要集中在已经盈利的龙头企业和少数接近盈利的准龙头企业。这些企业已经有商业化产品在销售，且销售数据在持续改善。投资者愿意为这些"已验证的兑现能力"支付溢价。但板块中大量的Biotech企业，尤其是那些还没有商业化产品或者第一个产品刚上市不久的企业，估值仍然处于较低水平，没有享受到明显的风险偏好外溢。

第二，资金流入呈现结构性特征，而非系统性特征。从资金流向来看，增量资金更多地集中在少数几只龙头标的，而不是分散配置到整个板块。这符合过渡态的特征——投资者先选择最安全的、最确定的标的进行配置，等待更多验证信号出现后，再向其他标的扩散。如果是终局态，资金应该呈现更均匀的分布，因为整个板块的基本面都已经被认可。

第三，板块的波动率仍然较高，对政策事件和业绩数据的敏感度很强。过渡态的典型特征就是不确定性仍然较高，市场对任何超预期的政策或业绩都会给予积极反应，但对任何低于预期的数据也会给予负面反应。如果是终局态，板块的走势应该更加稳定，因为基本面已经充分定价，短期的政策或数据波动不会引发大幅的估值调整。

第四，创新药板块与大盘和其他板块的相对估值仍然处于历史中枢偏上位置，但没有出现极端溢价。这说明投资者对这个板块是看好的，但还没有到疯狂追逐的程度。这种谨慎的乐观态度也符合过渡态的特征——看好，但还在观察。

当前不宜用"全面配置扩散期"的框架来理解创新药板块。板块确实在改善，但这种改善是渐进的、结构性的、分层次的。投资者需要区分"已经在验证的龙头"和"还在等待验证的二线"，不能简单地认为整个板块会同步上涨。

■ 外溢需要多样本同时跨过瓶颈阶段

板块风险偏好的全面外溢，需要满足一个关键条件：足够多样的样本同时跨过商业化瓶颈阶段。这个条件目前还没有完全满足。

商业化瓶颈阶段是指创新药企业从第一个产品上市到实现稳定盈利之间的那段过渡期。企业需要完成医院准入、医生教育、患者支付、供应链建设、销售团队扩张等一系列复杂任务。任何一个环节卡住，都可能导致产品放量不达预期，企业持续亏损。只有当一个企业的商业化流程跑通，收入增速稳定，利润率改善，经营性现金流转正，才算真正跨过了瓶颈阶段。

目前创新药板块的情况是，只有少数龙头企业已经明确跨过了瓶颈阶段。这些企业有多个商业化产品在售，医院覆盖广，单院产出高，财务报表上已经能看到持续的盈利和现金流改善。它们的存在证明了在中国创新药的商业化路径是可以跑通的，这为整个板块提供了信心基础。

但跨过瓶颈阶段的企业数量还不够多。板块中大量的Biotech企业仍然处于瓶颈阶段之中，有的产品刚上市不久，医院覆盖还在初期；有的产品虽然进了医保，但单院产出爬坡缓慢；有的企业销售团队还在搭建中，学术推广能力有限。这些企业如果不能在未来一到两年内展现出清晰的盈利路径，就会拖累板块的整体风险偏好外溢。

板块风险偏好的全面外溢，需要的是一个“样本扩散”的过程。投资者需要看到越来越多的企业从“还在瓶颈中”转变为“已经跨过瓶颈”。每多一家企业实现稳定盈利，板块的可投资范围就扩大一分，增量资金的选择余地就增加一分，估值修复的广度就加深一分。当跨过瓶颈阶段的企业数量达到一个临界值，比如占到板块总市值的一定比例，或者占到投资者关注标的的一定比例，资金就会从结构性配置转向系统性配置，板块的风险偏好外溢就会从龙头溢价扩散为整体估值中枢上移。

这个临界值目前可能还没有达到。当前的投资策略更适合在龙头企业中精选已经验证的标的，同时密切跟踪二线品种的经营变量和验证变量，等待更多样本跨过瓶颈阶段的信号出现。在此之前，把板块外溢等同于全面配置扩散，可能会过度乐观。

CHAPTER 05

板块系统性流入是四层变量逐级接力的过程

■ 系统性流入不是单一事件触发的线性结果

资本市场里，人们总是倾向于寻找那个“决定性时刻”。但创新药板块的系统性资金流入，从来就不是这种单一事件触发的线性叙事。它不是某一次医保谈判结果公布、不是某一份临床试验数据读出、不是某一轮降息周期开启，甚至不是某一份国务院文件印发。真正的系统性流入，是四个层次变量在时序上逐级接力、在空间上相互嵌套之后，才会涌现出来的宏观结果。

这四个层次分别是：宏观贴现率、板块盈利可见度、资金迁移路径与政策叙事强度。它们之间的关系不是简单的并列，而是像一条接力赛道上的四个选手，每一棒都必须稳稳接住上一棒传来的火炬，才能让整体奔跑速度加快。如果第一棒选手跑得很快，但第二棒掉棒了，比赛就会在那一刻停滞。创新药板块的行情也是如此——宏观环境改善是必要条件，但远不是充分条件。

宏观贴现率的变化，通常由无风险利率和全球流动性环境驱动。当十年期国债收益率下行、美联储进入降息周期、或者国内货币政策边际宽松时，创新药这种远期现金流占比极高的资产类别，理论上会享受估值扩张。因为创新药公司的价值主要藏在多年以后——管线上市、销售放量、利润兑现。这些现金流越遥远，对贴现率的变化就越敏感。一个贴现率从8%降到6%的微小变化，足以让一家Biotec h的净现值提升三成甚至五成。市场常常把创新药板块视为“利率敏感型资产”，原因就在这里。

但贴现率改善本身，只能解释估值修复，不能解释资金持续流入。估值修复更像是一次性的重新定价：利率下降了，所有远期现金流资产的估值分母变小了，价格自然向上跳一格。但跳完这一格之后呢？如果板块的盈利可见度没有同步改善，资金就会陷入一种尴尬的处境——估值看起来比过去便宜了，但不知道便宜之后会不会更便宜，因为盈利预期还在下修。配置型资金尤其如此，它们的决策周期以季度甚至年度为单位，不会因为利率降了50个基点就大幅调仓，它们需要看到更确定的东西。

■ 四层变量必须逐级接力，缺一不可

让我们把四层变量拆开来看，看看它们各自在什么阶段发挥作用，以及为什么缺一不可。

第一层是宏观贴现率。它的作用是为整个板块创造一个“估值友好的环境”。当贴现率下行时，创新药板块的估值中枢会系统性上移，这是数学上的必然。但宏观贴现率对板块的提振是普惠性的——它几乎对所有高估值、远期现金流型资产都有帮助，包括AI算力、半导体、甚至部分消费成长股。所以仅凭贴现率改善，资金没有理由独宠创新药，它完全可以选择其他同样受益于利率下行的赛道。2024

年下半年到2025年初，全球创新药指数和纳斯达克生物科技指数都曾因降息预期而阶段性走强，但同期AI算力板块的涨幅更为惊人。这说明资金在利率下行周期里，并不是天然流向创新药，而是流向当时盈利可见度更高的方向。

第二层是板块盈利可见度。这才是创新药板块区别于其他远期资产的核心竞争力。盈利可见度指的是：市场能否对板块内多数公司的未来两到三年的收入和利润，形成一个相对可信的预测区间。这个预测区间不需要非常精确，但需要足够稳定，不能让投资者觉得明年的数字可能上下波动50%。创新药板块的盈利可见度，在过去几年一直处于极低水平——管线失败率太高、商业化路径太长、政策不确定性太强，导致分析师的盈利预测像是一张随时会被撕掉的草稿纸。但当多目录协同体系开始运转，当更多创新药从"上市"走向"医保"再走向"基药"和"院端落地"，盈利可见度就开始改善了。投资者可以开始用"覆盖医院数乘以单院产出"这种更商业化的框架来估算收入，而不是用"概率加权峰值销售乘以成功概率"这种管线期权框架。这种估值框架的切换本身，就是盈利可见度提升的标志。

第三层是资金迁移路径。即使宏观贴现率和盈利可见度都改善了，资金也不一定会流入创新药板块，因为资金在当前时刻可能已经被其他板块"锁定"。如果AI算力或半导体板块正处于业绩兑现的高峰期，资金没有动力大规模切换。资金迁移需要一个"推力"和一个"拉力"：推力是其他板块的性价比下降或拥挤度上升，拉力是创新药板块的相对吸引力上升。这个相对吸引力，不仅取决于创新药自身变好，还取决于其他赛道有没有变差。如果其他高景气成长赛道同时也有很强的基本面支撑，资金迁移就会非常缓慢，甚至不会发生。这就是为什么我们需要观察"跨板块估值差"的原因——资金不是看创新药自己便不便宜，而是看创新药相对于它可能替代的方向，便不便宜。

第四层是政策叙事强度。创新药板块有一个特殊之处：它的政策敏感性极高。医保谈判、基药目录调整、商保创新药目录、DRG/DIP支付改革、药械审批加速，每一项政策都能在短期内引发市场情绪的剧烈波动。但政策叙事对资金流入的影响是双刃剑：一方面，密集的政策出台可以制造一种"产业趋势被官方确认"的氛围，吸引趋势跟踪型资金；另一方面，如果政策只是零散的、一次性的、没有形成协同效应的，市场很容易把它解读为"政策脉冲"而非"制度演进"。政策叙事要达到推动系统性流入的强度，必须满足三个条件：一是多环节协同（支付、准入、配备、处方不能各自为政），二是可预期性强（市场能大致预判下一步政策的方向），三是可验证性高（政策效果能在季度数据中体现）。

只有当这四层变量形成接力——宏观贴现率改善创造估值空间，盈利可见度提升吸引配置资金，资金迁移路径打通让实际持仓变化发生，政策叙事强度维持让市场情绪不提前冷却——系统性流入才会真正发生。缺少任何一环，行情都会停留在"反弹"或"主题交易"的层面，而无法升级为"配置型增配"。

■ 利率改善是必要条件但不是充分条件

过去几年的市场经历反复教育了投资者一个道理：利率下行不等于创新药牛市。2020年全球大放水期间，创新药板块确实享受了估值泡沫，但2022年美联储加息之后，板块的跌幅也远超大盘。更微妙的是，在2024年至2025年这段全球利率逐步回落的周期里，创新药板块的表现是阶段性的、分化的，而不是持续的、普涨的。这背后的关键差异，就在于盈利可见度有没有同步改善。

让我们做一个思想实验。假设某个时点，十年期国债收益率从4%降到了3%，宏观环境对创新药非常有利。但同期，板块内多数公司的盈利预测被分析师连续下修——因为医保谈判降价幅度超预期、因为院端准入进展缓慢、因为竞品上市挤压了市场份额。在这种情况下，虽然估值分母变小了，但分子（预期现金流）也在变小，甚至变小得更快。结果是，板块的远期估值并没有真正提升，或者只是短暂提升后迅速回落。这时候进入的资金，很快就会发现“估值陷阱”——看起来便宜了，但便宜的逻辑是盈利预期崩塌，而不是市场错误定价。

反过来，如果利率没有明显改善，但盈利可见度因为多目录协同而大幅提升，创新药板块会出现什么？答案是：会出现结构性行情，而非系统性流入。个别已经证明商业化能力的公司会吸引资金，但板块整体不会普涨，因为宏观环境仍然压制着高估值资产的总体吸引力。资金会在板块内部寻找确定性，而不是把整个板块当作一个配置单元。这就是为什么我们强调“必要条件不等于充分条件”——利率改善是系统性流入的门票，但拿到门票不意味着一定能进场，还需要盈利验证这张座位票。

历史上不乏这种“只有利率改善、没有盈利修正”的伪行情。最典型的特征是：板块在利率下行初期跟随大盘反弹，但反弹幅度弱于其他高景气赛道；龙头公司表现尚可，但中尾部公司跟涨乏力；成交额放大几天后迅速萎缩，显示资金并未持续流入。这种行情的本质是“估值修复反弹”，而不是“配置资金持续流入的起点”。区分两者的关键，是看反弹之后有没有出现盈利预测的上修和机构持仓的净增。如果有，反弹可能升级为反转；如果没有，反弹就只是反弹，最终还是会回到原来的趋势中去。

■ 盈利修正滞后于利率改善时，行情容易夭折

在四个变量中，宏观贴现率通常是最先变化的，因为利率环境对宏观经济数据的反应相对灵敏。而盈利可见度的变化往往滞后，因为创新药从政策出台到收入兑现，中间隔着医院准入、药事会审议、临床路径更新、科室处方采纳等多个环节，每一个环节都需要时间。这种时间差造成了一个常见的市场现象：利率改善已

发生了，但盈利数据还没有跟上来，行情在预期和现实的夹缝中摇摆。

这个阶段是最危险的。市场的乐观情绪会先把股价推上去，推到一个需要盈利验证才能支撑的水平。如果验证来得太晚，或者验证结果不及预期，股价就会从高位回落，回落的幅度往往比上涨的幅度更剧烈，因为前期入场的资金会同时出逃。这种“先涨后跌”的剧本，在创新药板块已经反复上演过多次。投资者需要学会识别这种“预期透支”的状态：当板块的整体远期估值已经回到历史中枢以上，但盈利预测的上修幅度还没有跟上，就是一个警示信号。

更隐蔽的风险是，即使盈利数据最终跟上来，但如果跟上的速度太慢，市场可能已经失去了耐心。资金的记忆是短暂的，一个季度没有兑现，就会有资金开始质疑叙事的可持续性；两个季度没有兑现，质疑就会变成共识，资金从观望转向撤离。所以，创新药板块的系统性流入，不仅需要盈利改善，还需要盈利改善的节奏足够快，快到能在市场耐心耗尽之前完成验证。这也是为什么政策传导效率如此重要的原因——政策不能只是出台了，还要能快速转化为医院覆盖、处方量和收入数字，否则时间差会吃掉所有估值空间。

CHAPTER 06

资金流入先发生在认知切换后发生在持仓切换

■ 最早变化的通常是投资框架而非成交额

如果我们要观察资金流入的最早迹象，应该看什么？很多人第一反应是看成交额、看北向资金、看板块相对强弱。但这些指标都是资金流入的结果，而不是原因。在资金真正进场之前，更先发生的是认知层面的切换——投资者看待创新药板块的方式变了，这种变化发生在持仓变化之前，甚至发生在价格变化之前。

投资框架的切换是什么？它指的是投资者从用一种估值逻辑看创新药，切换到用另一种估值逻辑。具体来说，就是从“管线驱动”框架切换到“商业化驱动”框架。在管线驱动框架下，创新药公司的价值取决于在研管线的数量、阶段、适应症空间、竞品格局，以及最终的峰值销售概率。投资者关心的是临床试验的成功率、监管审批的进度、授权交易的金额。公司的估值更像是一篮子期权的加权价值，现金流极为遥远，波动极大。

而在商业化驱动框架下，投资者关心的则是：产品已经上市了没有？进了医保没有？进了多少家医院？单院产出是多少？销售团队的执行力如何？竞争格局有没有恶化？这种框架下，估值锚从“远期概率”切换到了“近期现金流”，从“能不能成”

切换到了"能卖多少"。这种切换本身，就是认知层面最重要的变化，因为它决定了资金是否愿意把创新药从"主题交易池"移到"核心配置池"。

认知切换通常发生在什么时候？往往不是某一个大事件之后，而是多个小事件积累到临界点的时刻。当市场连续看到几家创新药公司的季度收入超预期，当看到医保谈判的降价幅度比预期温和，当看到基药目录首次批量纳入创新药，当看到这些政策确实转化为了医院覆盖数字的上升——这些碎片化的信息一点一点拼接起来，最终让投资者意识到：创新药板块不再是那个只能讲故事的板块了，它开始具备按商业化能力排序的配置价值。这种认知的变化，不会在任何单一交易日以成交量的形式爆发出来，但它会悄悄地改变投资者在未来的每一次调仓决策。

■ 认知切换从龙头开始验证

认知切换不会同时发生在所有投资者身上，也不会同时覆盖板块内所有公司。它总是从龙头公司开始，因为龙头公司拥有最充分的信息、最透明的预期差、最容易量化的验证路径。资金在尝试一个新的投资框架时，本能地会选择试错成本最低的标的。什么是试错成本最低？就是那些即使我错了，也能快速知道错在哪里的公司。

龙头公司通常是已经有一到两个产品商业化兑现、收入体量和增速都相对清晰、机构覆盖度高、管理层沟通频繁的公司。对于这类公司，投资者可以比较容易地建立"覆盖医院数×单院产出"的预测模型，可以在每个季度结束后验证模型的准确性，可以及时调整预期。这种"可验证性"是认知切换得以发生的前提。如果一个公司连收入都还没有，谈何验证商业化模型？投资者只能继续用管线概率框架来估值，认知切换就无从谈起。

认知切换的先后顺序是：先龙头，后板块中位数，最后尾部。这个顺序不是人为选择的，而是信息密度决定的。龙头公司信息密度高，认知切换成本低；尾部公司信息密度低，认知切换成本高。只有当龙头公司的认知切换被验证了——也就是用商业化框架估值确实能赚钱——投资者才会把这种框架外推到第二梯队、第三梯队。否则，谁会愿意在一个信息黑洞里尝试新的投资逻辑呢？

■ 持仓切换滞后于认知切换数周甚至数月

认知切换发生了，持仓切换就一定会立刻跟上吗？不一定。从"我想买"到"我买了"，中间隔着一道复杂的决策流程，尤其是配置型资金。

对于公募基金经理来说，调仓需要经过研究部推荐、基金经理决策、风控合规审核、交易执行等多个环节。一个板块从"进入关注列表"到"实际进入前十大重仓"，可能需要一到两个季度。对于保险资金和养老金来说，周期更长，因为它们的投

资决策需要经过更严格的资产负债匹配分析和长期风险收益评估。即使是外资，虽然交易执行速度较快，但板块层面的配置调整也需要经过全球资产配置委员会的审议，不是某个基金经理一拍脑袋就能决定的。

这种滞后性意味着：在认知切换和持仓切换之间，存在一个“时间窗口”。在这个窗口期，认知已经变了，但持仓还没有变，价格可能已经开始反映一部分预期，但远没有完全反映。对于敏锐的跟踪者来说，这个窗口期是观察和布局的最佳时机。怎么识别这个窗口期？关键指标不是成交额——因为持仓切换还没发生，成交额不会显著放大——而是分析师报告的频率和措辞变化、机构调研的密集度、以及龙头公司相对大盘的估值扩张是否先于板块整体。

■ 龙头验证先于板块扩散是降低试错成本的必然路径

资金从龙头向板块扩散，不是简单的“赚钱效应外溢”，而是有更深层的行为金融学逻辑。配置资金在面对一个不确定的板块时，最优策略是“分批试探、逐级验证”。第一批资金进入龙头，如果龙头在接下来的一到两个季度里兑现了商业化预期，验证了“多目录协同→医院覆盖提升→收入增长”这个传导链条，那么第二批资金就会进入第二梯队；如果第二梯队也表现不错，第三批资金才会进入第三梯队和更广泛的板块。每一批资金都在用前一批资金的验证结果来降低自己的试错成本。

这种“龙头先行、板块扩散”的次序，在几乎所有新兴板块的历史走势中都能观察到。它不是创新药特有的现象，而是资金在不确定性环境下的理性选择。反过来，如果资金一开始就大举涌入板块中尾部，往往说明行情更接近主题炒作——因为主题炒作不需要验证，只需要情绪。但主题炒作的持续性是最差的，一旦情绪退潮，资金会同时撤离，留下一地鸡毛。真正能够形成系统性流入的板块，一定是先经历过龙头验证阶段的。

龙头验证阶段的长度，取决于两个因素：一是龙头公司的业绩兑现节奏，如果龙头连续两三个季度超预期，验证速度就会加快；二是板块内可供扩散的标的数量，如果板块内只有极少数公司具备商业化能力，扩散就会很快结束，板块行情也会很快变成个股行情。创新药板块在2025年至2026年的特殊性在于：随着越来越多的Biotech公司从管线阶段进入商业化阶段，可供扩散的标的池正在扩大，这为龙头验证后的板块扩散提供了基础。

CHAPTER 07

跨板块估值差收敛是配置迁移前提

■ 配置资金切换时先看相对估值分位差

配置资金做板块切换的时候，脑子里想的从来不是“这个板块自己好不好”，而是“这个板块相对于我正在持有的板块，值不值得换”。这是一个非常关键的思维差异。交易型资金可能会因为某个板块自身出现利好而追涨，但配置型资金的决策逻辑是相对比较——不是绝对判断。

这种相对比较的第一步，就是看估值分位差。具体来说，就是看创新药板块相对于当前市场最热门的高景气成长赛道（比如AI算力、半导体）的估值分位差，是否处于历史低位。为什么是历史低位？因为配置资金换仓的动机，通常不是“创新药变好了”，而是“其他赛道变得太贵了，而创新药又太便宜了”。只有当这种极端的估值分位差出现时，配置资金才有足够的安全边际和预期差空间来推动大规模调仓。

估值分位差的历史低位意味着什么？它意味着市场在过去几年里，对创新药板块的定价是极度悲观的。这种悲观可能来自多方面：pipeline失败率高、商业化路径长、政策不确定性大、出海受挫等等。但当多目录协同开始改变这些悲观假设的底层逻辑时，估值分位差就构成了一个“弹簧”——被压缩得越狠，反弹的力度就越大。配置资金进入的时点，往往就是这个弹簧被压缩到极限、但基本面边际改善已经开始发生的时刻。

■ 仅有估值便宜不足，需要“相对吸引力边际变化”

但估值便宜本身是不够的。如果创新药板块一直都很便宜，配置资金为什么没有早来？因为“便宜”是一个静态概念，而资金切换需要的是“变得更便宜”或者“别人变得更贵”。也就是说，关键不在于估值分位差的绝对水平，而在于这个分位差的边际变化方向。

假设在某个时点，创新药相对AI算力的估值分位差处于历史最低的10%分位。这看起来是一个很好的入场信号。但如果这个分位差在过去一年里一直处于10%分位附近，没有继续恶化，也没有改善，配置资金就不会有紧迫感——反正已经在这个位置趴了很久，再等等也无妨。真正触发资金行动的，是边际变化：比如AI算力因为业绩兑现不及预期而出现估值下修，同时创新药因为医保谈判结果温和而出现估值上修，两股力量共同推动估值分位差从极端低位开始收敛。这种“相对

吸引力边际变化"才是配置资金切换的扳机。

更精确地说，配置资金需要看到的不是"创新药估值低"，而是"创新药相对于替代方向的性价比正在快速改善"。这种改善可以来自三个渠道：一是创新药自身基本面改善导致估值修复；二是替代方向基本面恶化导致估值下修；三是两者同时发生。其中，第三种情况的切换力度最强，因为两边都在推动资金流向创新药。历史上，板块间大规模资金迁移往往发生在这种"双击"时刻。

■ 仅有盈利改善而估值不便宜，容易演变为个股行情

反过来，如果创新药板块的基本面确实在改善，盈利预测在上修，但估值已经 not 便宜了——比如板块整体估值已经回到了历史中枢以上，甚至接近高位——那么资金的行为模式就会完全不同。这时候，配置资金不会进行板块层面的系统性切换，而是在板块内部进行个股精选。因为板块层面的估值空间已经不大了，只有那些盈利上修幅度远超板块平均的个别公司，才值得超配。

这种场景下，创新药行情更容易演变为"个股行情"而非"系统性板块行情"。表现特征是：龙头公司因为业绩超预期而持续上涨，但中尾部公司跟涨乏力；板块内部涨跌分化加剧，而不是普涨；板块的相对强弱指数没有系统性抬升，只是个别权重股在贡献涨幅。对于想要捕捉板块beta的配置资金来说，这种行情没有足够的吸引力，因为beta空间已经压缩了。

可持续的板块切换需要同时满足两个条件：一是相对估值分位差处于历史低位（有空间），二是盈利修正差正在扩大（有动力）。前者提供了安全边际，后者提供了上涨催化剂。缺少前者，资金不敢大规模进来；缺少后者，资金没有进来的理由。这两个条件缺一不可，共同构成了配置资金从观望转向行动的核心前提。

■ 估值分位差与盈利修正差的组合决定行情性质

如果我们把"相对估值分位差"和"盈利修正差"这两个维度组合起来，就可以得到一个判断行情性质的四象限矩阵：

第一象限：估值分位差低，盈利修正差扩大。这是最好的组合，对应"系统性板块行情"。配置资金既有安全边际，又有基本面改善的催化剂，板块层面的beta和个股层面的alpha都有空间。历史上，大部分可持续的中期板块行情都发生在这个象限。

第二象限：估值分位差高，盈利修正差扩大。这是"个股行情"的组合。基本面在改善，但估值空间已经不大，资金只能在内部精选个股。板块整体表现可能平平，但个别公司会有超额收益。这种行情对选股能力要求高，对板块配置价值不大。

第三象限：估值分位差高，盈利修正差收窄。这是最差的组合，对应"板块调整"。基本面在恶化，估值又贵，资金会系统性撤离。这时候不仅板块没有配置价值，个股也很难独善其身，因为整体估值中枢下移会带动所有公司估值压缩。

第四象限：估值分位差低，盈利修正差收窄。这是"估值陷阱"的组合。看起来便宜，但便宜的原因是基本面在恶化。资金可能会被低估值吸引而入场，但很快就会发现"越买越便宜"，因为盈利预期还在下修。这种行情最迷惑人，也最容易让价值投资者踩坑。

创新药板块在2025年至2026年的关键问题，就是判断自己处于哪个象限。如果多目录协同能够推动盈利修正差从收窄转为扩大，同时估值分位差仍然处于相对低位，那么板块就具备从第四象限向第一象限切换的条件。但这个切换不会自动发生，需要数据验证，需要时间窗口，需要资金信心的逐步建立。

CHAPTER 08

三类指标须分阶段使用：RS、北向、成交额

■ RS对趋势启动最敏感但极易受情绪污染

相对强弱指数（RS）是衡量一个板块相对于大盘或其他基准指数的价格强弱的指标。它通常以某个时间窗口内的价格比率来计算，比如创新药指数除以沪深300指数，或者港股创新药指数除以恒生指数。当RS持续上升时，说明板块在跑赢大盘，这是趋势启动的早期信号。

RS的优势在于反应速度快。当资金开始流入一个板块，哪怕只是试探性的、小规模的价格也会相对大盘率先走强，RS会在第一时间捕捉到这种走强。如果投资者希望尽可能早地识别板块趋势的萌芽，RS是最灵敏的工具之一。在创新药板块的历史走势中，几次中等级别的反弹，RS都是在价格突破前期平台之前就开始拐头上行的。

但RS的最大弱点，也是它反应速度快的副产品——它极易受到短期情绪和噪音的污染。一个突发政策利好、一则临床数据读出、一篇券商深度报告，都可能在短期内推动某几只创新药权重股大涨，从而带动RS快速跳升。但这种跳升可能并不代表系统性资金流入，而只是交易型资金的短期博弈。如果投资者看到RS上升就立即判定板块行情启动，很容易在情绪高点追进去，随后遭遇回调。

更隐蔽的陷阱是：RS的上升可能来自板块内少数几只权重股的拉动，而不是板块内多数公司的普涨。如果龙头企业因为自身利好而大涨，但板块中位数股票表现

平平，RS仍然会上升，但这时候的RS上升反映的是个股alpha，而非板块beta。如果投资者误把个股行情当作板块行情，就会在后续扩散不及预期时被套。

■ 北向持仓变化对风格切换有指示性

北向资金（通过沪深港通流入A股的外资）的持仓变化，是观察配置资金动向的重要窗口。与交易型资金相比，北向资金的行为更接近配置型资金：持仓周期长、换手率低、决策更依赖基本面框架。因此，当北向资金持续净流入某个板块时，通常意味着外资机构对该板块的中期配置价值形成了共识。

北向资金对风格切换的指示性尤其值得关注。外资的决策框架通常是全球比较视角——他们会把A股的创新药板块与美股生物科技、欧洲制药进行横向比较，评估哪个市场的性价比更高。如果外资开始持续增持A股或港股创新药，往往说明在全球比较中，中国创新药的估值折价已经大到足以吸引长期配置资金的水平。这种全球视角的切换，通常比内资更慢，但一旦形成，持续性更强。

但北向资金也有其局限性。首先是样本范围问题：北向资金覆盖的A股创新药标的有限，很多港股Biotech不在北向资金的范围内，因此北向持仓变化不能完全代表整个板块的资金动向。其次是权重股影响问题：北向资金的持仓变化很大程度上受到少数大市值公司的影响，如果这些公司因为纳入MSCI指数或富时指数而被被动配置资金买入，可能会被误读为外资主动看好板块。最后是滞后性问题：北向数据的披露是T+1或T+2，等投资者看到数据时，资金可能已经流入了一段时间。

■ 板块成交额占比对扩散敏感但容易在中后段才显著抬升

板块成交额占比（即创新药板块成交额占全市场成交额的比例）是衡量资金参与度和市场关注度的直观指标。当这个比例持续上升时，说明越来越多的资金正在涌入这个板块，市场的注意力正在从其他方向转移过来。从历史经验看，板块行情进入中后段时，成交额占比往往会达到一个显著的高点，因为此时不仅配置资金在进场，交易型资金、散户资金、量化资金都在涌入，形成量价齐升的局面。

但成交额占比的最大问题是：它对扩散阶段的确认很有效，但对早期阶段的捕捉很迟钝。在行情初期，资金流入量相对较小，还不足以显著抬升全市场成交额占比。这时候，即使板块已经开始跑赢大盘，成交额占比可能仍然低迷。如果投资者把成交额占比作为早期入场信号，就会天然滞后——等看到成交额占比明显上升时，行情可能已经走了相当长的一段。

此外，成交额占比在高位的持续性也是一个风险信号。如果板块的成交额占比达到了历史极端高位，但基本面改善的步伐开始放缓，这往往意味着板块进入了拥挤状态。拥挤状态下，后续资金的接力不足，一旦有任何利空消息，就容易出现

快速回调。所以，成交额占比不仅是一个确认扩散的工具，也是一个识别阶段顶部的工具。

■ 最优顺序是RS早期捕捉、北向验证持续性、成交额识别扩散

既然三类指标各有优劣，那么最优的使用策略就是把它们放在不同阶段、承担不同功能：

第一阶段：用RS进行早期捕捉。在行情萌芽期，RS是最灵敏的雷达。投资者可以设定一个RS的观察窗口（比如20日或60日），当RS出现持续拐头上行时，将板块列入“重点关注名单”。但这个阶段不应急于大规模建仓，因为RS信号可能来自噪音或个股alpha，需要等待进一步确认。

第二阶段：用北向持仓变化验证持续性。如果RS上行之后，北向资金也开始持续净流入，这就提供了一个重要的交叉验证：价格强势不仅被交易型资金认可，也被配置型资金认可。北向资金的介入，说明行情可能具备中期持续性，而不是短期脉冲。这个阶段可以考虑逐步建仓，但仍然保持灵活性，因为北向资金的变化也需要时间来确认趋势。

第三阶段：用成交额占比识别扩散与拥挤。当北向持仓和RS都确认了之后，如果板块成交额占比也开始显著抬升，说明行情已经从少数龙头扩散到了更广泛的板块，市场参与度在提升。这是一个积极的信号，表明板块beta正在形成。但投资者也要同时关注成交额占比是否过快接近历史高位，如果接近高位，就要警惕拥挤风险，考虑适当降低仓位或提高止盈纪律。

如果顺序错误，就会天然滞后或误判。如果先用成交额占比来寻找早期机会，那几乎一定会错过行情前半段；如果先用北向资金来捕捉趋势启动，可能会因为北向的滞后性而入场偏晚；如果只用RS而不加验证，可能会被假信号误导。三类指标就像三个不同焦距的镜头，RS是广角镜头，看得早但模糊；北向是标准镜头，看得清楚但需要时间对焦；成交额是长焦镜头，看得晚但精确。只有按顺序切换镜头，才能完整地记录下整个行情的过程。

CHAPTER 09

最稳健先行指标体系是分层容错框架

■ 一票否决项：跨资产风险偏好恶化或盈利预期连续下修

在构建一个用于判断创新药板块系统性资金流入的先行指标体系时，最稳健的设计不是寻找“精确命中”的单一指标，而是建立一个“分层容错”的框架。这个框架的第一层，是“一票否决项”。它的作用不是告诉你什么时候应该买入，而是告诉你什么时候绝对不应该买入——即使其他信号看起来再好。

一票否决项包括两类核心风险。第一类是跨资产风险偏好显著恶化。具体表现包括：全球无风险利率快速抬升（如美联储突然转鹰、国内货币政策收紧）、汇率出现剧烈波动（如人民币快速贬值引发外资撤离）、避险资产大幅走强（如黄金、美元、美债收益率在风险事件中的异常波动）。当这些信号出现时，意味着整个市场的风险溢价在上升，所有高风险资产的估值都会受到压制。在这种情况下，即使创新药板块自身的基本面没有变化，资金也会出于避险考虑而撤离。这时候，任何板块内部的积极信号都是不可靠的，因为系统性风险会覆盖掉行业alpha。

第二类一票否决项是盈利预期的连续下修。如果分析师对创新药板块整体的一致盈利预期，在连续两个或两个以上季度出现下修，那么无论价格走势多么强劲，都不应该判定为系统性配置流入。因为盈利预期下修意味着板块的基本面假设正在被证伪，而价格强势可能只是来自流动性推动或情绪博弈，不具备持续性。历史上，很多“假突破”都是发生在盈利预期下修但价格仍因短期资金推动而上涨的阶段，最终这些突破都会因为基本面无法支撑而崩塌。

一票否决项的存在，让投资者避免在错误的时间框架内做出决策。它不是用来过滤所有机会的，而是用来过滤那些“看起来是机会、实际上是陷阱”的时刻。在一个长期有效的投资框架中，避免大错的贡献往往比抓住大机会的贡献更重要。因为大错会让本金永久损失，而大机会错过只是少赚一点。

■ 核心确认项：盈利预测修正与机构持仓改善至少有一项跟随价格信号

如果一票否决项没有触发，那么我们进入第二层——核心确认项。核心确认项的作用，是把“价格强势”从“交易性行情”中区分出来，确认它是否具备向“配置性行情”转化的基础。

核心确认项包括两个关键指标：一是盈利预测修正方向，二是机构持仓变化。这两个指标至少需要有一个与价格信号同向变化，才能确认行情的性质。具体来说：如果板块价格持续走强，同时分析师一致盈利预期也在上修，这说明价格强势有基本面支撑，不是纯粹的资金博弈。如果板块价格持续走强，同时机构持仓（如公募基金季报披露的重仓股占比、北向资金持仓比例）也在净增，这说明价格强势有配置资金支撑，不是纯粹的交易资金推动。

最理想的情况是两者同时出现：价格上行的同时，盈利预期在上修，机构持仓在增加。这构成了一个“三维共振”——价格、基本面、资金结构都在向好的方向运动。这种情况下，系统性流入的概率最高，行情持续性也最强。但如果只有一个维度确认，另一个维度持平甚至略有背离，也不应该立即否定行情，而是需要更密切的跟踪。比如，如果价格上行、持仓增加，但盈利预期暂时没有明显上修，可能说明配置资金在基于前瞻性判断提前布局，而分析师的盈利模型还在调整中。这种情况下，只要盈利预期没有下修，就可以保持谨慎乐观。

核心确认项的关键在于“至少一项跟随”。如果价格信号很强，但盈利预测和机构持仓都没有改善，那么价格强势更可能是由短期交易资金或情绪驱动的，这种行情的性质是交易性而非配置性的。交易性行情的寿命通常以周或月为单位，而不是以季度或年为单位，对于配置型投资者来说，不值得大举参与。

■ 辅助增强项：政策叙事强度与龙头公司业绩兑现

在核心确认项之上，还有辅助增强项。这些指标不是必需的，但如果它们也指向积极方向，就能进一步增强对行情持续性的信心。

辅助增强项之一是政策叙事强度。如果创新药板块正处于一个政策密集出台、且政策之间形成协同效应的窗口期，那么板块的风险溢价会系统性下降。具体来说，政策叙事强度可以从三个维度观察：一是政策的密度（单位时间内出台的政策数量），二是政策的协同度（不同政策之间是否形成互补而非冲突），三是政策的可预期性（市场能否提前预判下一步政策的方向）。当这三个维度都较强时，政策对板块的支撑就从“脉冲式”升级为“制度性”，这会让配置资金更愿意给予板块长期估值溢价。

辅助增强项之二是龙头公司的业绩兑现。龙头公司是板块的“温度计”，它们的业绩表现不仅反映自身经营状况，也反映整个板块的商业化环境。如果龙头公司连续多个季度的收入和利润都超出市场预期，并且超预期的来源是商业化的真实改善（如医院覆盖数增加、单院产出提升），而不是一次性因素（如资产出售、授权收入），那么这种业绩兑现就会向板块传递信心。投资者会基于龙头的验证，推断第二梯队、第三梯队也有类似的机会，从而加速板块扩散。

辅助增强项的特点是：它们本身不足以独立支撑行情判断，但能够为已经通过核心确认项的行情“锦上添花”。如果核心确认项已经通过，辅助增强项又很强，那么投资者可以适度提高仓位或延长持有周期。如果核心确认项通过但辅助增强项较弱，那么行情可能仍然成立，但持续性需要打折扣，投资者应保持更高的灵活性。

■ 拥挤校正项：自动降低趋势信号权重、提高基本面信号权重

最后一层是拥挤校正项。当板块行情持续了一段时间，价格已经大幅上涨，成交额占比接近历史高位，市场情绪变得非常乐观时，即使基本面仍然向好，也需要引入拥挤校正机制。因为资本市场有一个永恒的规律：当所有人都看好同一个方向时，这个方向的预期差就已经被榨干了，后续资金接力的动力不足，任何风吹草动都可能引发剧烈回调。

拥挤校正项的核心操作是：自动降低趋势信号（如RS、价格动量）的权重，同时提高基本面信号（如盈利预期、估值分位、单院产出数据）的权重。在行情早期，趋势信号的权重可以更高，因为那时候价格本身还没有反映太多预期，趋势上升意味着预期差在扩大。但在行情中后期，趋势信号已经包含了大量乐观预期，继续高权重使用趋势信号，就会陷入“追涨杀跌”的陷阱。

具体来说，当观察到以下拥挤信号时，就应该启动校正：一是板块成交额占比达到历史80%分位以上；二是板块内个股普涨，且涨幅与基本面相关性下降（即“鸡犬升天”）；三是市场舆论对创新药的讨论热度异常升高，非专业投资者也开始大量涌入；四是龙头公司估值已经修复到历史中枢以上，中尾部公司估值也出现非理性扩张。在这些信号出现时，即使RS仍在上升、北向仍在流入，投资者也应该保持警惕，因为趋势可能已经进入“最后一程”。

拥挤校正项的本质，是承认投资者在不同阶段需要不同的决策框架。早期重趋势，因为趋势是预期差的发射器；中后期重基本面，因为基本面是估值的锚。如果从头到尾只用一种框架，要么会在早期错过机会，要么会在晚期被套在山顶。一个成熟的先行指标体系，必须内置这种阶段切换的自动校正机制，而不是让投资者凭感觉去猜什么时候该变。

■ 分层框架的使用顺序与逻辑

把五层框架放在一起，它的使用逻辑是这样的：

首先，检查一票否决项。如果跨资产风险偏好恶化或盈利预期连续下修，无论其他信号多好，都不参与。这一步确保了大方向的正确性。

其次，如果一票否决项没有触发，观察核心确认项。价格强势的同时，盈利预测或机构持仓至少有一项在改善。这一步区分了交易性行情和配置性行情。

再次，如果核心确认项通过，观察辅助增强项。政策叙事和龙头业绩是否也在提供支撑。这一步评估了行情的“额外火力”。

最后，无论前面几层是否全部通过，持续监控拥挤校正项。如果市场进入拥挤状态，即使基本面仍然向好，也要降低仓位或提高风险意识。这一步保护了已经获

得的收益。

这个分层框架的优势在于它的"容错性"。它不是要求所有条件都完美满足才行动，而是允许一定程度的信号缺失，只要核心条件满足就可以参与。同时，它又通过一票否决项和拥挤校正项，设置了明确的风险边界，防止投资者在极端情况下犯大错。对于创新药这样一个高波动、高不确定性、高政策敏感性的板块来说，这种容错框架远比任何单一指标都更可靠，也更符合实际投资决策的复杂场景。
